

43 - 02-la constipation - Pr. Samlani

La constipation, les objectifs c'est reconnaître une constipation, reconnaître les signes d'alarme, être capable de mener une enquête diagnostique, et être capable de hiérarchiser les examens complémentaires. La constipation est un symptôme qui correspond à une insatisfaction lors de la défécation. C'est basé sur la fréquence, moins de 3 selles par semaine, ou bien la difficulté d'exonération, la difficulté d'aller à la selle, ou bien les deux.

C'est un motif de constipation qui est très fréquent, et il faut savoir faire la part des choses entre la constipation primitive et secondaire. C'est l'insatisfaction, que ce soit par le nombre de selles peu fréquente, ou par la nécessité d'un effort de poussée, ou bien par la sensation qu'on n'a pas été satisfait par cette selle, qui définit la constipation. Deux types de constipation peuvent être déterminés.

Il y a la constipation maladie, qui est la plus fréquente, isolée, ancienne. Elle reconnaît deux mécanismes. Soit une anomalie de progression due à une inertie colique, c'est-à-dire un colon qui ne fonctionne pas correctement, ou bien un colon qui est spastique.

Deuxième mécanisme, c'est l'anomalie d'évacuation, c'est-à-dire la dyskésie. On l'appelle également la constipation terminale. Donc deux types de constipation, soit une constipation de progression, soit une constipation terminale due à un problème d'évacuation.

Il y a également la constipation symptôme. Celle-ci est généralement récente, ou bien d'aggravation récente. C'est quelqu'un qui avait une selle normale et qui devient constipé.

Elle est secondaire et peut relever de, ou accompagner des processus pathologiques. Pour poser le diagnostic de la constipation, il faut passer par l'interrogatoire, savoir poser les deux questions fondamentales, quand est-ce que ce symptôme a été ou est apparu, et comment il est apparu. L'interrogatoire va rechercher les antécédents personnels, chirurgicaux, notamment la chirurgie proctologique, c'est-à-dire la chirurgie de fissures, d'hémorroïdes, les incisions d'abcès, de chirurgie digestive colorectale, de chirurgie urologique ou bien gynécologique.

L'interrogatoire va rechercher les antécédents médicaux, la notion d'aliment ou de prise de médicaments, et bien sûr les antécédents familiaux, notamment les antécédents de cancer colorectal. Il précisera également les circonstances, la date de survenue de ce symptôme, si la constipation est ancienne ou récente, les changements des conditions de vie et d'hygiène alimentaire, pour rechercher notamment une sédentarité récente, et la prise médicamenteuse, ou les prises médicamenteuses, notamment de l'axatif, ou bien d'autres médicaments, qui sont les OPSC, qui sont les neuroleptiques, etc. L'interrogatoire va également rechercher les signes associés, notamment les douleurs abdominales, les évacuations anormales, que ce soit le sang ou les glaires, et bien sûr le retentissement sur l'état général, l'amaigrissement, la perte d'appétit.

L'examen physique est important, il passe par l'examen abdominal, la vérification de l'état de la

peau abdominale, s'il y a des cicatrices, une hernie, une éventration, et bien sûr l'examen de la région anopérinéale, à la recherche de fissures, d'abcès ou de prolapsus. Donc vous voyez ici en haut à gauche un prolapsus rectal, en haut à droite une fissure anal, et en bas un prolapsus hémorragulaire. Donc il est évident que si l'on a ce genre de pathologie, on ne peut pas aller à la selle de manière correcte, et ça peut être une cause de constipation.

L'examen physique passera impérativement par le toucher rectal, qui va rechercher la présence d'une sténose anal ou rectale, s'il y a une contracture paradoxale du sphincter anal, on peut suspecter un anisme, et la présence de matière dans l'ampoule rectale sera en faveur d'une dyskésie rectale. L'examen ou le toucher rectal sera complété par le toucher vaginal, à la recherche de lésions gynécologiques qui peuvent envahir ou comprimer le rectum et entraîner une constipation. Quels sont les examens complémentaires à réaliser quand on est face à une constipation ? Ces examens sont en fonction de l'orientation, et ils visent essentiellement à éliminer une cause organique, c'est-à-dire une constipation secondaire à une maladie d'encane.

L'anuscopie permet d'explorer l'anus, la rectoscopie le rectum, et la coloscopie l'ensemble du cadre colique, permettant ainsi d'éliminer un cancer ou une sténose, et même de réaliser des biopsies. En fonction de l'orientation clinique, on peut doser les hormones thyroïdiennes, parce qu'une hypothyroïdie peut être responsable d'une constipation, faire une calcémie, une kaliémie, une fonction rénale, ou d'autres examens biologiques. Quand on suspecte une constipation fonctionnelle, on peut mesurer le temps du transit colique.

Quand on suspecte un problème terminal ou ce qu'on appelle un syndrome de descente pelvienne, une défécographie, une défécoïère peut être réalisée. Dans ce cas-là, les clichés sont pris alors que le patient est assis en pleine poussée, et ça permet d'étudier les organes. Quand on pense à un problème de motricité anorectale, une manométrie anorectale peut être réalisée.

Une coloscopie doit être réalisée quand il y a des signes d'alarme, un amaigrissement, une anémie, la présence de sang ou d'éclairs. Quand la constipation est récente, avec des signes d'appel colique ou bien quand il y a une aggravation d'une constipation ancienne, et bien sûr quand il y a des signes en faveur d'une cause organique. C'est-à-dire, si à l'examen on retrouve une masse abdominale, si on retrouve une hépatomégalie en faveur d'une hépatomégalie tumorale ou bien des ganglions, et qu'on a une constipation, il faudra bien sûr penser à la pathologie tumorale et réaliser une coloscopie.

C'est ainsi que l'on peut scinder les étiologies de la constipation. En constipation organique, dont les causes peuvent être digestives, notamment cancer colorectal, des tumeurs bénignes, des sténoses coliques ou anorectales, le mégacolon idiopathique ou la maladie de Hirschsprung, la pathologie proctologique qu'on a vu, les fissures, les hémorroïdes, etc. Les causes endocriniennes métaboliques peuvent également provoquer une constipation.

C'est le cas de l'hypothyroïdie, de l'hyperparathyroïdie, l'insuffisance rénale et de l'hypocalcémie.

Les causes neurologiques également, le diabète, la maladie de Parkinson, un accident vasculaire cérébral risque de provoquer une constipation, la dépression, la démence. La prise de médicaments également.

Il faut savoir que certains médicaments, notamment les opiacés, les neuroleptiques, les anticonvulsivants, peuvent provoquer une constipation. Dans ce cas-là, c'est l'interrogatoire qui peut poser le diagnostic. Deuxième catégorie d'étiologie, ce sont les constipations maladies.

Dans ce cas-là, on a soit les constipations ou la constipation par anomalie de progression. Le patient va rapporter des douleurs abdominales vagues, un ballonnement, mais sans besoin entre les exonérations. La cause de cela, c'est l'inertie colique ou bien le côlon spastique.

C'est un problème de la motricité colique. Soit la constipation maladie par anomalie d'évacuation. C'est la constipation qu'on dit terminale par difficulté d'exonération.

Dans ce cas-là, le patient va vous rapporter qu'il va à la selle difficilement en poussant, que parfois il met son doigt pour évacuer son anus. Quand vous allez faire le toucher rectal, vous allez retrouver des selles. Parmi les étiologies de cette constipation terminale, on a l'anisme, qui est la contracture paradoxale du sphincter, et on a le syndrome de périnée descendant, c'est-à-dire la descente d'organes, qui est surtout présent chez les femmes, multipart ou après la ménopause.

Je vous ai dit que le diagnostic pouvait être fait par cliniquement et bien sûr par déphécographie et déphécoïère. Les principales complications de la constipation sont le fécalum, qui est la présence de matière dure dans l'ampoule rectale, qui touche surtout le sujet âgé, qui va avoir des douleurs abdominales, des douleurs péloviennes. Le toucher rectal va retrouver une ampoule qui est pleine.

Le diagnostic sera posé cliniquement, parfois à l'aide aussi d'une imagerie, un ASP ou un scanner. Le traitement sera bien sûr l'évacuation pour soulager ce patient. Deuxième complication, ce sont les rectoragies secondaires aux traumatismes dus à la poussée, aux manœuvres digitales.

Troisième complication, c'est le prolapsus, qu'il soit hémorroïdaire ou à terme, par les efforts de poussée répétée et pendant longtemps, un prolapsus rectal. En conclusion, la constipation est un symptôme qui est fréquent. Il est important de différencier la constipation organique de la constipation maladie, pour pouvoir choisir les examens complémentaires, pour pouvoir arriver à l'étiologie, parce que le traitement est étiologique.